

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE ACTITUDES HACIA LA ALIMENTACIÓN (EAT-26)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Cribado de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Actitudes hacia la Alimentación - Versión Breve de 26 Ítems (EAT-26).
Nombre Original (Inglés)	<i>Eating Attitudes Test - 26 Item Version (EAT-26)</i>
Autores Originales	David M. Garner, Marion P. Olmsted, Yvonne Bohr y Paul E. Garfinkel (1982).
Adaptaciones Españolas	Castro, Toro, Salamero y Guimerá (1991, validación española de referencia); Gandarillas et al. (2003).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado poblacional y clínico de patología alimentaria.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 26 reactivos politómicos de 6 anclajes con corrección asimétrica (0, 0, 0, 1, 2, 3).
Población y Rango	Población adolescente y adulta (≥ 12 años). Cribado escolar, atención primaria y medicina del deporte.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, preventivo y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO PSICOPATOLÓGICO DE LOS TCA

El EAT-26 es la reducción factorial estandarizada del EAT-40 original (Garner y Garfinkel, 1979), optimizada para maximizar la sensibilidad diagnóstica y reducir la redundancia en estudios epidemiológicos y cribados clínicos masivos. Su constructo evalúa las actitudes cognitivas disfuncionales hacia el peso, la silueta corporal y la alimentación restrictiva o purgativa.

El modelo factorial del EAT-26 identifica tres dimensiones psicopatológicas nucleares: el impulso hacia la delgadez y restricción calórica severa (**Dieta**), los episodios descontrolados de ingesta con rumiación o purgas (**Bulimia**), y la presión ambiental percibida junto con la vigilancia obsesiva de la comida (**Control Oral**). Constituye el instrumento de cribado de primera línea recomendado por organizaciones internacionales para la detección precoz de Anorexia y Bulimia Nerviosa.

3. ESTRUCTURA TRIFACTORIAL DEL EAT-26 (GARNER ET AL., 1982)

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Psicopatológica
1. Dieta (Restricción)	1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26	0 a 39	Miedo patológico a engordar, rechazo de hidratos de carbono, pesaje obsesivo y deseo continuo de perder peso.
2. Bulimia y Preocupación	3, 4, 9, 18, 21, 25(inv)	0 a 18	Pensamientos intrusivos sobre comida, atracones descontrolados y vómitos inducidos postprandiales.
3. Control Oral	2, 5, 8, 13, 15, 19, 20	0 a 21	Lentitud forzada al comer, cortar la comida en trozos diminutos y percepción de que otros presionan para comer.
PUNTUACIÓN TOTAL EAT-26	1 al 26	0 a 78	Índice acumulativo de actitudes alimentarias patológicas y riesgo de TCA.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.90 a 0.93 en muestras clínicas españolas con TCA y de 0.86 a 0.88 en población comunitaria (Castro et al., 1991).
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte estándar <i>ge20</i> : sensibilidad del 88% y especificidad del 93% en la detección de casos confirmados según criterios DSM-IV y DSM-5.
Validez Concurrente	Elevada correlación con el Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI-2 / EDI-3 $r = 0.82$) y con la subescala de insatisfacción corporal del BSQ ($r = 0.74$).
Poder Discriminante	Distingue con gran precisión estadística entre pacientes con Anorexia o Bulimia y controles sanos o sujetos que realizan dietas normativas saludables.
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.84$ a las tres semanas en adolescentes escolares estables.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PONDERACIÓN ASIMÉTRICA

El EAT-26 utiliza un sistema de calificación asimétrico diseñado para puntuar únicamente las respuestas clínicamente desviadas:

- **Ítems Directos (Ítems 1 al 24 y 26):**

Nunca = 0 | Casi nunca = 0 | A veces = 0 | A menudo = 1 | Muy a menudo = 2 | Siempre = 3

- **Ítem 25 Invertido (“Disfrute probando comidas nuevas”):**

Siempre = 0 | Muy a menudo = 0 | A menudo = 0 | A veces = 1 | Casi nunca = 2 | Nunca = 3

- **Puntuación Total:** Suma de los 26 reactivos corregidos. Rango: **0 a 78 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO (CASTRO ET AL., 1991; GARNER, 1982)

Estrato	Puntuación	Estado de Riesgo	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo	0 a 9	Actitudes alimentarias normales	Ausencia de preocupación patológica por el peso. Educación nutricional habitual.
Medio	10 a 19	Preocupación estética / Dieta moderada	Insatisfacción corporal leve o dieta situacional. Vigilancia evolutiva en adolescentes.
Riesgo	20 a 30	Corte Clínico Positivo (Riesgo TCA)	Punto de corte estándar. Sospecha firme de TCA en desarrollo. Entrevista diagnóstica formal.
Severo	31 a 78	Patología Grave / Trastorno Activo	Elevadísima gravedad psicopatológica. Derivación inmediata a Unidad Especializada de TCA.

CRITERIO DE ALERTA INDEPENDIENTE POR PREGUNTAS CONDUCTUALES: Incluso con una puntuación total inferior a 20 puntos, la presencia de vómitos provocados, uso de laxantes/diuréticos, atracones recurrentes o una pérdida ponderal brusca (> 5 kg en el último mes) constituye un **positivo clínico inmediato** que exige valoración médica urgente.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SEGÚN EL PERFIL FACTORIAL:

- **Predominio en Factor Dieta y Control Oral:** Perfil restrictivo típico de Anorexia Nerviosa (Tipo Restrictivo). Suele asociarse a IMC bajo, perfeccionismo rígido y alexitimia; requiere monitorización somática estricta y restablecimiento ponderal.
- **Predominio en Factor Bulimia:** Episodios de descontrol alimentario con conductas compensatorias purgativas (Bulimia Nerviosa o Anorexia Tipo Purgativo). Alto riesgo de hipopotasemia y arritmias; abordaje prioritario cognitivo-conductual (Fairburn) y nutricional estructurado.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: CRIBADO ESCOLAR EN ADOLESCENTE

Paciente: Chica de 16 años, estudiante de 1.º de Bachillerato, remitida por el departamento de orientación tras una campaña de despistaje escolar debido a desmayos en clase de gimnasia y aislamiento a la hora del almuerzo.

Resultados EAT-26:

• **Puntuación Total:** 38/78 (**Rango Severo — Cribado Positivo**).

• **Desglose factorial:** Factor Dieta = 27/39 (puntuaciones máximas en terror a engordar, evitación de comida con grasas y pesarse diariamente); Factor Control Oral = 8/21 (cortar alimentos diminutos y sentir que la presionan para comer); Factor Bulimia = 3/18.

• **Exploración médica:** IMC = 15.8 kg/m² (desnutrición moderada-severa), hipotermia (35.4 °C), bradicardia sinusal (46 lpm) y amenorrea secundaria de 5 meses.

Conducta Asistencial: Se diagnostica Anorexia Nerviosa Restrictiva Grave. Se deriva de forma preferente al Hospital de Día de Trastornos de la Conducta Alimentaria para estabilización médica, reintroducción nutricional protocolizada y terapia familiar basada en el modelo Maudsley. A los 6 meses, la paciente alcanza un IMC saludable de 19.5 kg/m² y el EAT-26 desciende a 12 puntos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO

ALERTA: RIESGO VITAL SOMÁTICO

Criterios de derivación a Urgencias: IMC < 14, bradicardia < 40 lpm, hipotensión (< 80/50 mmHg), prolongación del intervalo QTc, síncope o desequilibrio electrolítico grave (K⁺ < 3.0 mEq/L).

RIESGO AUTOLÍTICO COMÓRBIDO

Los TCA presentan una de las mayores tasas de mortalidad en psiquiatría, tanto por complicaciones biológicas como por suicidio consumado (especialmente en subtipos purgativos).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The Eating Attitudes Test: psychometric features and clinical correlates. *Psychological Medicine*, 12(4), 871–878.
2. Castro, J., Toro, J., Salameiro, M., & Guimerá, E. (1991). The Eating Attitudes Test: Validation of the Spanish version. *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 3(3), 343–352.
3. Gandarillas, A., Zorrilla, B., Sepúlveda, A. R., & Febrel, C. (2003). Prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en la Comunidad de Madrid. *Documentos Técnicos de Salud Pública*, 85.
4. Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(5), 509–528.